

환자 및 보호자 배포용 안내서 [이비인후과]

1. 수술 전날 준비사항

가. 자정(24:00) 이후 전면 금식

- 수술 전날 밤 12시부터는 물, 껌, 사탕을 포함하여 아무것도 드시면 안 됩니다. 마취 중 위 내용물 역류로 인한 합병증을 방지하기 위함입니다.

나. 복용 중인 약물 확인

- 아스피린, 와파린, 플라빅스 등 혈전용해제/항응고제는 수술 후 출혈 위험을 높이므로 의료진의 지시에 따라 반드시 사전에 중단되어야 합니다. (혈압약 등 당일 아침 꼭 드셔야 하는 약은 간호사의 안내를 따르세요.)

다. 신체 위생 및 물품 제거

- 수술 전날 저녁 가볍게 샤워를 하시고, 손발톱의 매니큐어나 젤네일은 반드시 제거해 주세요. (수술 중 산소포화도 및 말초 순환 측정을 위함입니다.) 보청기, 속옷, 틀니, 피어싱, 반지 등 모든 장신구는 수술실 입실 전 제거합니다.

라. 수술 전 목 운동 연습

- 수술 중에는 목을 뒤로 젖힌 자세를 장시간 유지하게 됩니다. 수술 전날 가벼운 목 스트레칭을 해두시면 수술 후 발생할 수 있는 뒷목 결림이나 통증을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다.

2. 수술 후 필수 모니터링 및 합병증 대처법

가. 위험 징후: 수술 부위 출혈 (수술 직후 가장 주의)

- 갑상선 주변은 혈류가 매우 풍부하여 수술 초기 내부 출혈로 피가 고이면 기도를 압박해 숨이 차는 증상이 발생할 수 있습니다. 24시간 이내 아래 증상이 느껴지면 즉시 의료진을 불러주세요.
- 자가 관찰 증상: 목 내부가 심하게 조이거나 숨쉬기 답답함, 목 뒤나 상처 주변이 갑자기 부풀어 오름, 침을 삼킬 때 극심한 이물감, 수술 부위가 피로 과도하게 젖음.
- 대처법: 즉시 간호사 호출 벨을 누르고, 말을 자제하며 심호흡을 합니다. 기침을 하거나 목에 강한 힘을 주지 마시고 상체를 30도 정도 높게 올린 자세를 유지합니다.

나. 증상 관찰 : 일시적 저칼슘혈증 (부갑상선 자극)

갑상선 수술 후 일시적으로 몸 안의 칼슘 수치가 낮아져 근육에 자극이 올 수 있습니다.

- 전절제 환자: 입원 기간 중 피검사를 통해 칼슘 수치를 지속적으로 확인하며 안전하게 퇴원 일정을 결정합니다. (평균 수술 후 2일 이내 퇴원결정)
- 반절제 환자: 반대편 부갑상선이 잘 보존되어 있어 영구적인 위험은 없으나, 수술 후 일시적인 자극으

로 며칠간 가벼운 증상이 있을 수 있습니다. (수술후 다음날 퇴원)

- 3) 자가 관찰 증상: 입술 주위, 손끝, 발끝이 찌릿찌릿하거나 저린 느낌, 안면 근육의 떨림.
- 4) 대처법: 증상이 인지되면 참지 말고 간호사에게 말씀해 주세요. 주사 처치나 알약 복용을 통해 수분 내에 쉽게 호전되므로 불안해하실 필요 없습니다.

3. 배액관 유무에 따른 식사 및 퇴원 안내

환자분의 수술 소견에 따라 목에 배액 주머니(Hvac)를 달고 나오는 경우와 없이 나오는 경우가 있습니다.

가. 배액관(주머니)을 가지고 나온 경우

- 1) 초기 배액량 비우기: 수술 후 병동 침상에 도착한 후 첫 1시간 동안 나오는 분비물은 수술 직후 자연스럽게 고여서 나오는 양이므로 의료진이 확인 후 한 번 비워 드립니다. 그 이후부터 나오는 양을 기준으로 하루 총 배액량을 정확히 측정하게 됩니다.
- 2) 식사 시작: 수술 당일에는 금식 및 약만 복용합니다. 수술 다음 날 아침, 배액관에 고인 액체로 TG(중성지방) 검사를 시행합니다. 림프액 유출 유무를 안전하게 확인한 후 최종적으로 저지방식이 식사를 시작합니다.
- 3) 퇴원: 식사 진행 후 배액관을 통해 나오는 분비물의 양이 안전하게 줄어들면 주치의 판단하에 관을 제거하고 최종 퇴원합니다.

나. 배액관이 없는 경우

- 1) 식사 시작: 마취가 완전히 풀리고 위장 기능이 안정되면 조기에 일반식사로 즉시 진행합니다.
- 2) 퇴원: 수술 부위에 특별한 출혈 징후가 없고 통증 조절이 잘 된다면, 대개 수술 다음 날(익일) 오후 2-3시경 퇴원이 가능합니다. 퇴원 직전 압박 붕대는 제거합니다.

4. 수술 후 상처 관리 지침

가. 목 수술 절개 부위 (더마본드 사용 시)

- 1) 피부 표면에 의료용 피부 접착 본드(더마본드)가 붙어 있어 상처를 밀봉 보호합니다. 입원 기간 및 퇴원 후에도 별도의 소독약 도포나 거즈 소독은 절대 하지 않습니다.
- 2) 입원 중 처방받으신 흉터 연고는 본드가 붙어 있는 동안에는 바르지 마시고, 교수님 외래 방문 날 반드시 지참해 오세요. 외래에서 의료진이 본드를 제거한 후 바르는 정확한 시기를 안내해 드립니다.

나. 배액관을 제거하고 퇴원한 부위

- 1) 배액관을 뺀 자리는 구멍이 완전히 아물 때까지 매일 1회 집에서 자가 소독(제공된 소독약 사용)을 해주셔야 합니다.
- 2) 감염을 막기 위해 상처가 완전히 붙을 때까지는 물이 절대 닿지 않도록 각별히 주의해 주십시오. (샤

워 시 방수 패드 사용 권장)

5. 외래 추적 관찰 일정표

수술하신 요일에 따라 퇴원 후 외래 방문 일정이 다르게 짜여 있으니 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
(상황에 따라 대기시간이 길어질수있으니 양해 바랍니다)

가. 월요일 수술 환자용 일정

- 1) 1차 외래 (다음주 월요일): 일반의 진료
가) 반절제(H/T) 환자:경부 초음파 검사 시행
나) 전절제(T/T) 환자:경부 초음파 검사 + 혈액 검사시행
- 2) 2차 외래 (다음주 금요일): 박재홍 교수님 진료
가) 공통 사항: 외래 방문 당일 혈액 검사 및 경부 초음파 시행

나. 목요일 수술 환자용 일정

- 1) 1차 외래 (다음주 수요일): 일반의 진료
가) 반절제(H/T) 환자:경부 초음파 검사 시행
나) 전절제(T/T) 환자:경부 초음파 검사 + 혈액 검사 시행
- 2) 2차 외래 (그 다음주 화요일): 박재홍 교수님 진료
가) 공통 사항: 외래 방문 당일 혈액 검사 및 경부 초음파 시행

다. 외래 내원 시 필수 주의사항

- 1) 혈액 검사 안내: 혈액검사 결과가 나오는데 시간이 소요되므로, 반드시 본인의 외래 진료 시간 최소 2시간 전에 채혈실에 방문하여 혈액검사를 완료해 주셔야 합니다.
- 2) 초음파 검사 안내: 초음파 검사는 당일 예약된 외래 진료 시간에 맞추어 내원하신 후 안내에 따라 검사를 진행하시면 됩니다.
- 3) 복용중이던 아스피린, 와파린, 플라빅스 등 출혈 유발 약물등은 대개 수술후 5일째 복용시작합니다 (퇴원시 반드시 확인하시고 복용해야 합니다)
- 4) 진단서는 최종 조직검사 결과 확인후에 작성 가능합니다,